Folkhälsa

Vecka	Torsdag	Fredag
2	Introduktion till Folkhälsa ämnet Genomgång + diskussion	Arbetshäfte med begrepp båda lektionerna
3	Genomgång Gruppresentation om två länder	Gruppresentation om två länder båda lektionerna
4	Presentation!	Presentation båda lektionerna!
5	E-quiz begreppen från arbetshäftet	Vetenskaplig undersökning om hälsa - Repetition av vetenskapsteori
6	Vetenskaplig undersökning om hälsa	Vetenskaplig undersökning om hälsa
7	Vetenskaplig undersökning om hälsa	Vetenskaplig undersökning om hälsa

Vad innebär Hälsa?

Hälsa

Vad innebär Hälsa?

Hälsa

Hur man mår

Fysisk hälsa
- Fri från sjukdomar

Psykisk hälsa
- Fri från psykiska sjukdomar
- Stabil mentalt

Träning
- Konditionsträning tränar lungorna hjärtat
- Styrketräning förebygga skador
- längre hälsosammare liv

Förebygga depression

Kost
- Varierad kost förebyggar / minskar risken för sjukdomar.

13-13.4

Naturkuns

Idag

- Introd

Hälsa

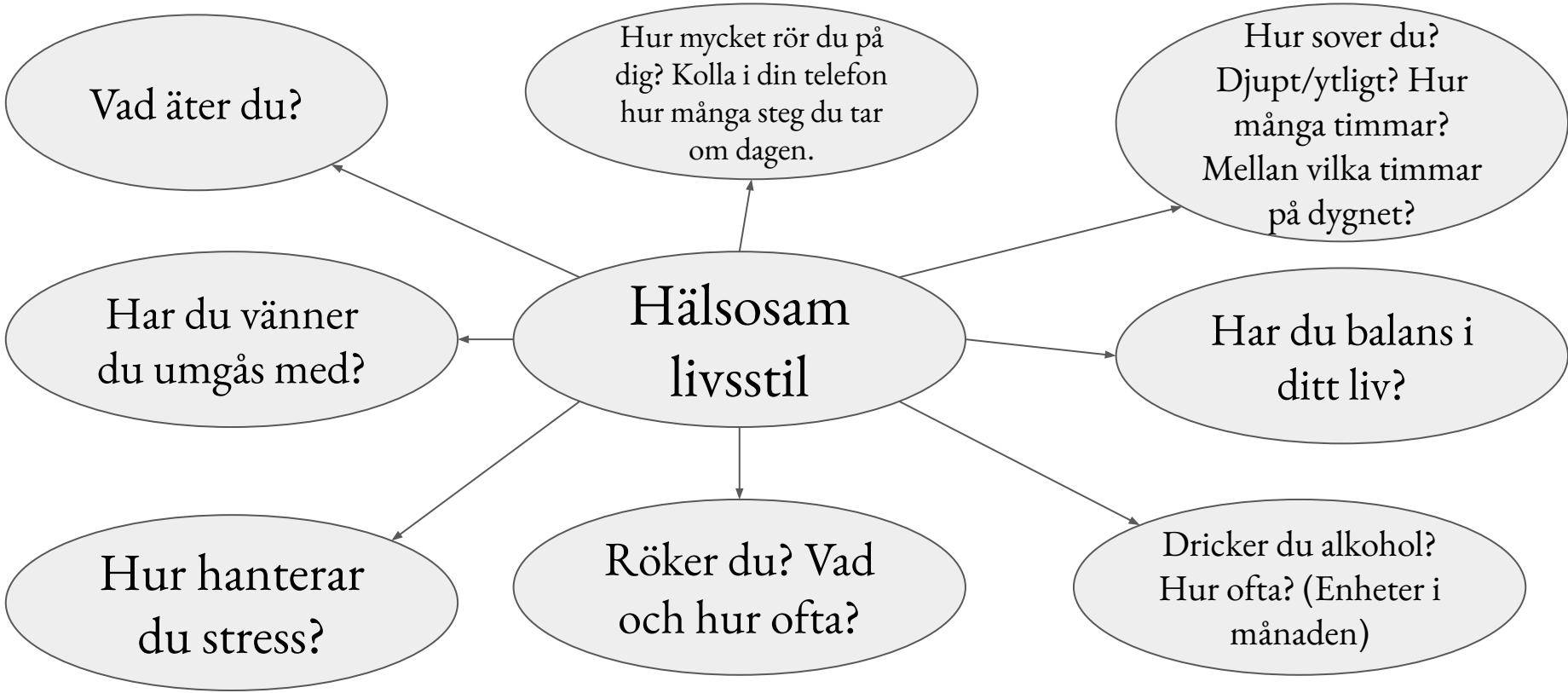
Patogent perspektiv

Fri från sjukdom
Att vara hälsosam är samma sak som att inte ha en sjukdom
Fokus här är att “fixa” sjukdomar så att en återställer till “normal” hälsa

Salutogent perspektiv

Att vara hälsososam handlar om att vara frisk nog att leva sitt bästa liv
Främja livskvalitet och välbefinnande
Fokus på att stärka det som är bra i ens liv så man blir tuff nog att hantera problem

Vad innebär en hälsosam livsstil?



Vad är då folkhälsa?

Samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd

Folkhälsan bör vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa.

Folkhälsa

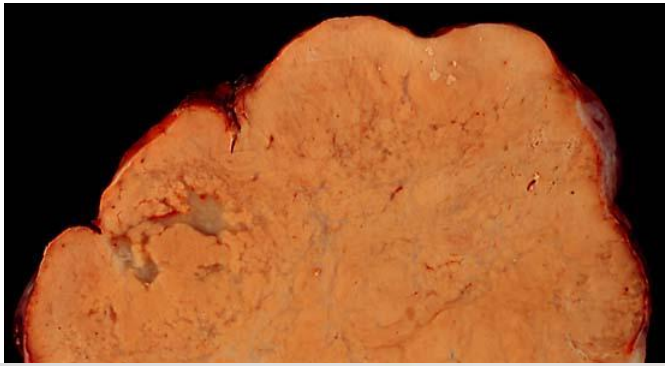
Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen.

Folksjukdom & folkhälsoproblem

Folksjukdom är en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.

Vanliga folksjukdomar i Sverige är diabetes, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Folkhälsoproblem kan definieras av att det drabbar minst en procent av befolkningen och innebär allvarliga konsekvenser för drabbade personer och samhället i stort.



Ojämlikhet i hälsa

Ojämlikhet i hälsa kan beskrivas som systematiska skillnader i hälsa mellan grupper med olika social position.

Social position handlar om vilken ställning människor har i olika sammanhang i samhället. När social position baseras på utbildningsnivå, yrke eller inkomstnivå kallas det för socioekonomisk position.

Ofta är människors hälsa bättre ju högre socioekonomisk position de har.
de som har mer resurser från början också har bättre förutsättningar att få ökade resurser och en bättre hälsa.

Problemet med ohälsa

För **individen** kan det handla om försämrade eller förlorade levnadsår, lägre inkomst, mindre möjligheter att påverka både sitt liv, samhället i stort och sin sociala position.

För **samhället** kan det handla om kostnader kopplade till vård och omsorg liksom kostnader kopplade till produktionsbortfall på grund av sjukdom.

Hur mår Sverige?

Generellt bättre hälsa – men ökade skillnader mellan grupper

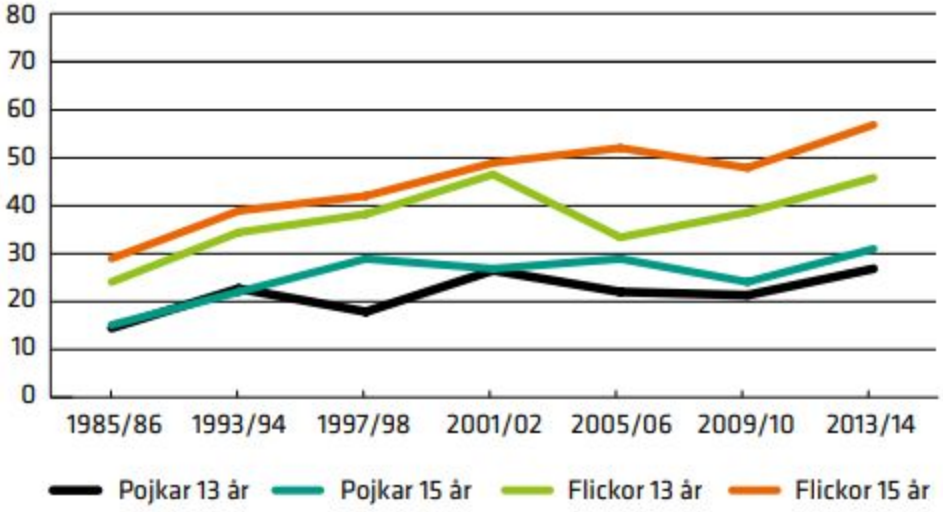
Vi lever längre och färre vuxna dör innan de fyllt 65 år. Medellivslängden ökade med drygt 2 år i befolkningen mellan 2006 och 2022. Men hälsan skiljer sig åt mellan olika grupper. Hälsoklyftorna mätt i medellivslängd har ökat, tvärtemot riksdagens mål om att sluta klyftorna. Skillnaden i medellivslängd mellan gruppen med kortast och längst utbildning har stigit till drygt 6 år bland män och nästan 7 år bland kvinnor. Kvinnor i gruppen med kortast utbildning har dessutom haft en negativ utveckling av medellivslängden, en minskning med cirka ett halvt år.

– Att investera i hälsa är samhällsekonomiskt gynnsamt. En god och jämlik hälsa i befolkningen bidrar till samhällets utveckling och motståndskraft. Vi behöver intensifiera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Insatser behöver genomföras brett och med särskilt fokus på de grupper som har sämst hälsa där insatserna gör störst skillnad, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folhälsomyndigheten.

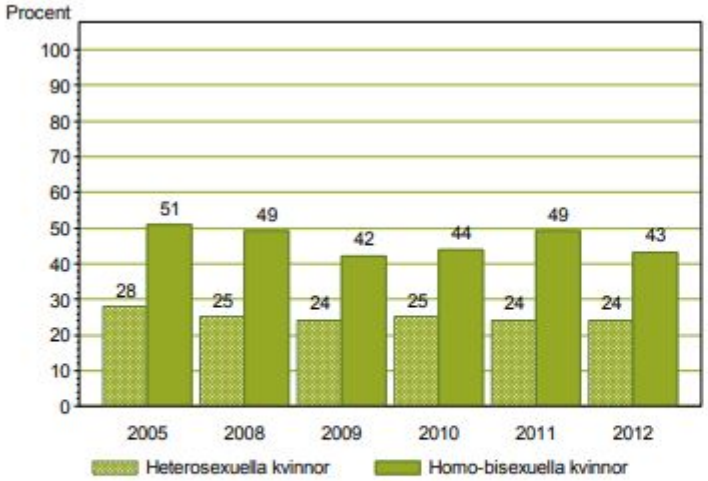
Ökad psykisk ohälsa bland tonåringar

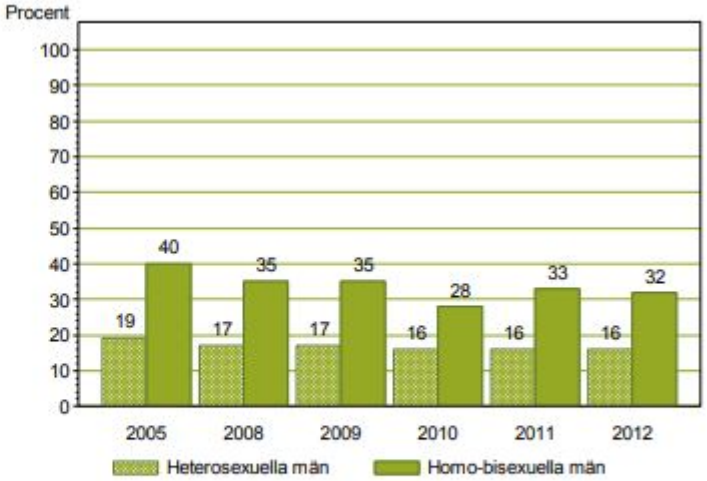
De senaste 30 åren har självrapporterade somatiska och psykiska besvär, såsom huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet, ökat bland 13- och 15-åringar i Sverige (se faktaruta ”Att mäta psykisk ohälsa”).

Figur 1. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de har haft minst två somatiska eller psykiska besvär mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna, 1985/86-2013/14

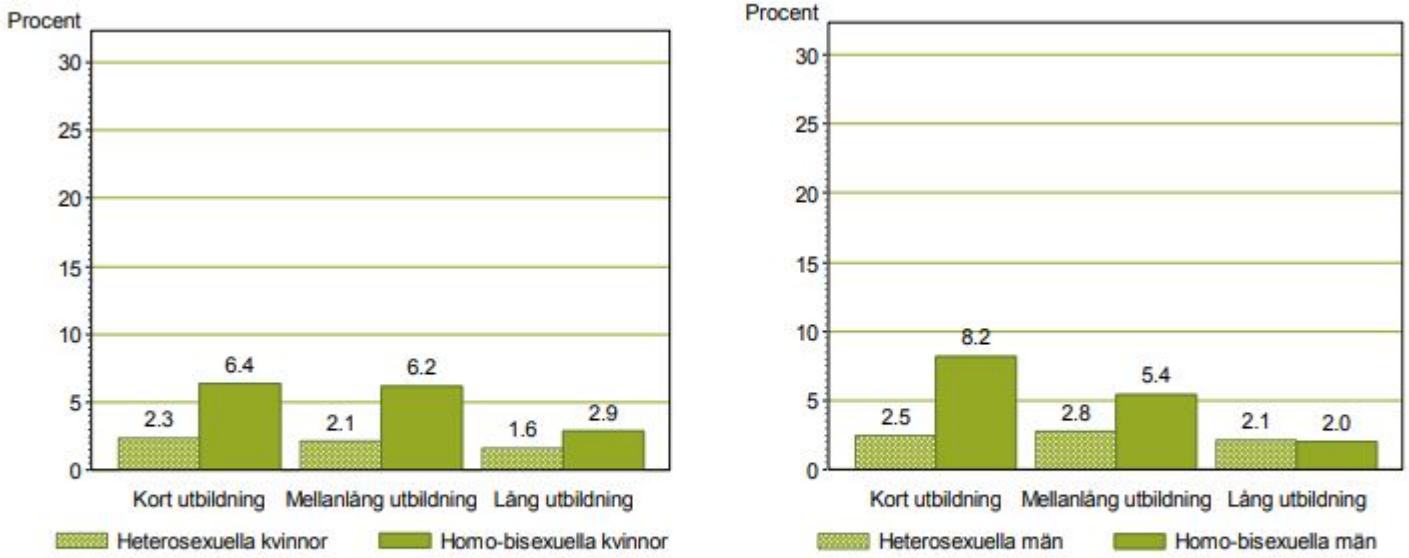


Anm. Uppgifter för år 1989/90 saknas.





Figur 1 Andel kvinnor och män (16–64 år) som under de tre senaste månaderna blivit behandlade/bemötta så att de känt sig kränkta, fördelat efter kön, sexuell läggning och år.

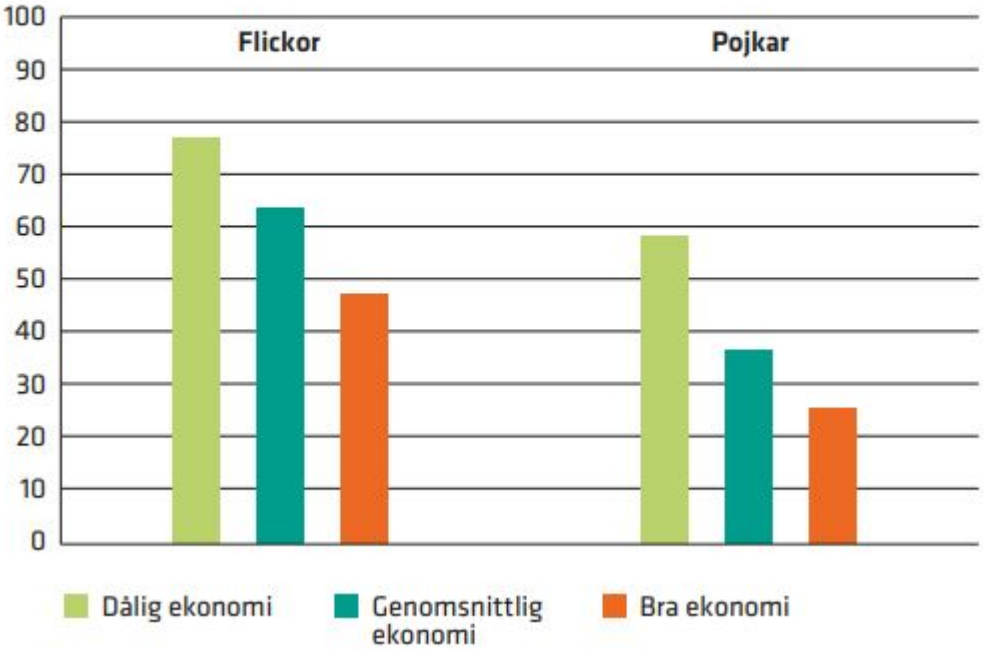


Figur 5 Andel kvinnor och män (25–64 år) under de 12 senaste månaderna som blivit utsatta för fysiskt våld, fördelat efter sexuell läggning och utbildning, 2010–2012.

Statistik – hälsa mellan olika grupper i Sverige

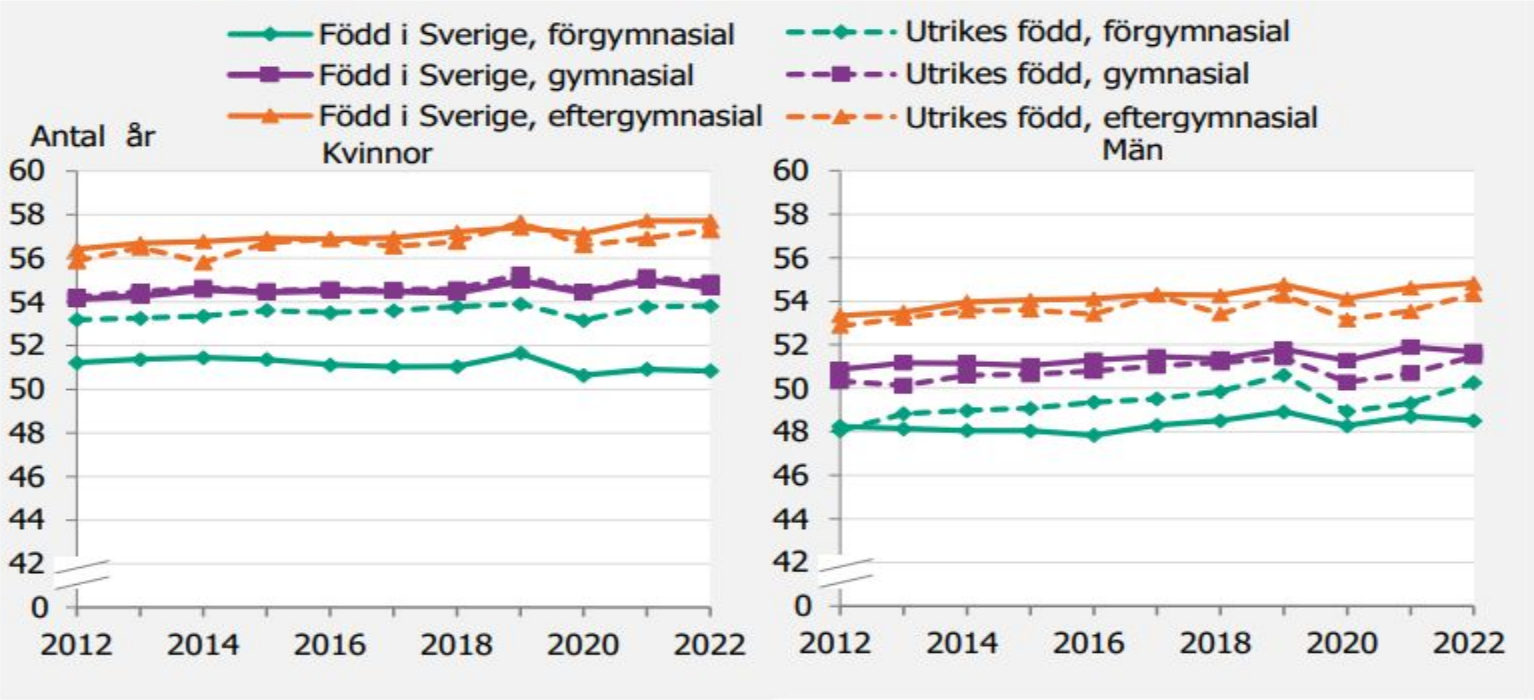
Skillnad mellan socioekonomiska grupper i psykosomatiska besvär (exempelvis huvudvärk som följd av ångest)

Figur 5. Andelen (%) 13- och 15-åringar som har uppgett minst två psykosomatiska besvär, mer än en gång i veckan, fördelade efter sin uppfattning om familjens ekonomi 2013/14



Skillnad i “återstående medellivslängd efter kön, utbildningsnivå & födelseregion

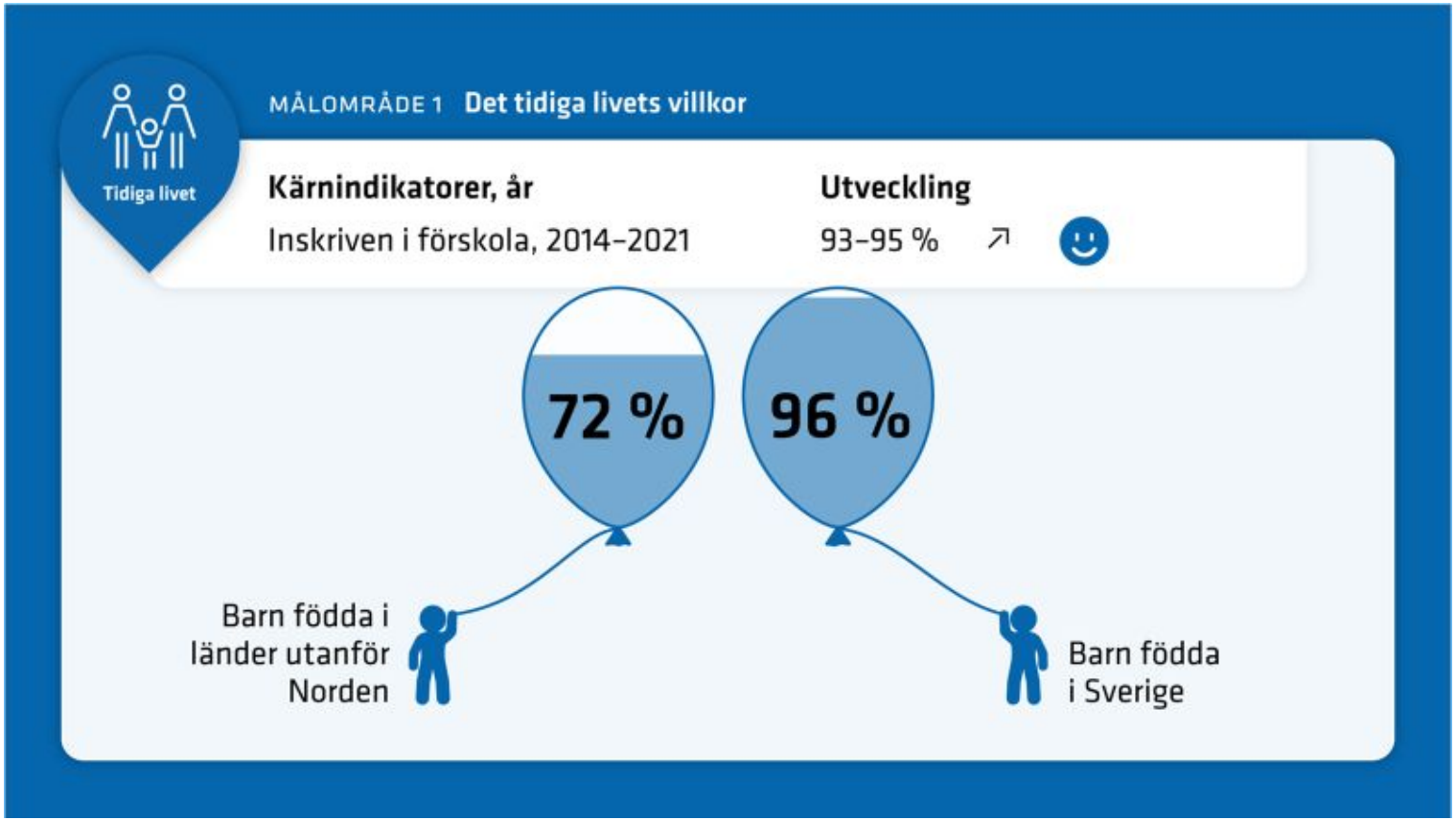
Diagram 2. Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter kön, utbildningsnivå och födelseregion, 2012–2022.



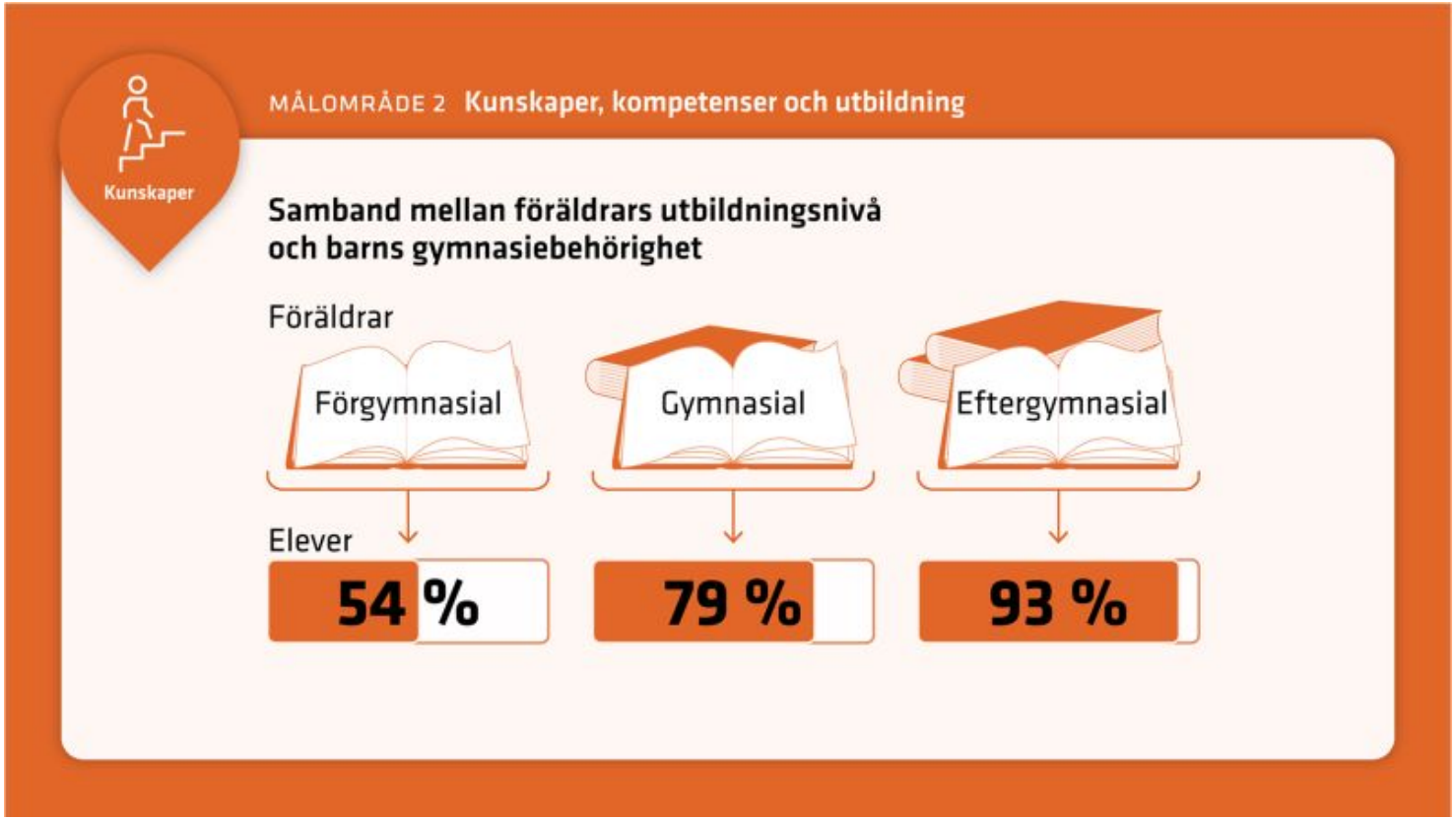
Källa: SCB, Statistikdatabasen, Befolkning, Demografisk analys. Hämtat 2023-08-22 från: Ettårig livslängdstabell efter

Varför tror ni att vissa grupper är friskare än andra?

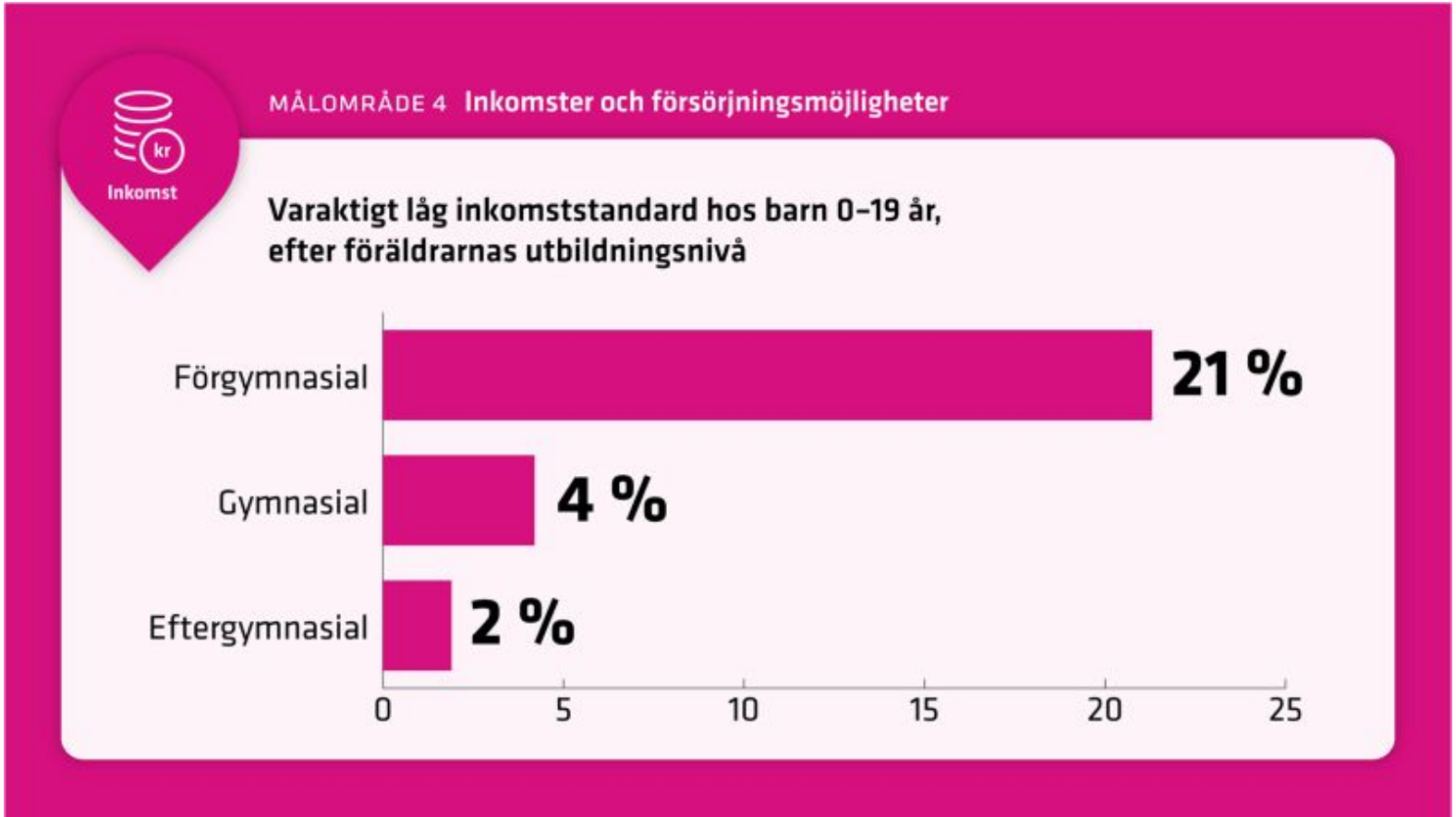
Folkhälsan i Sverige



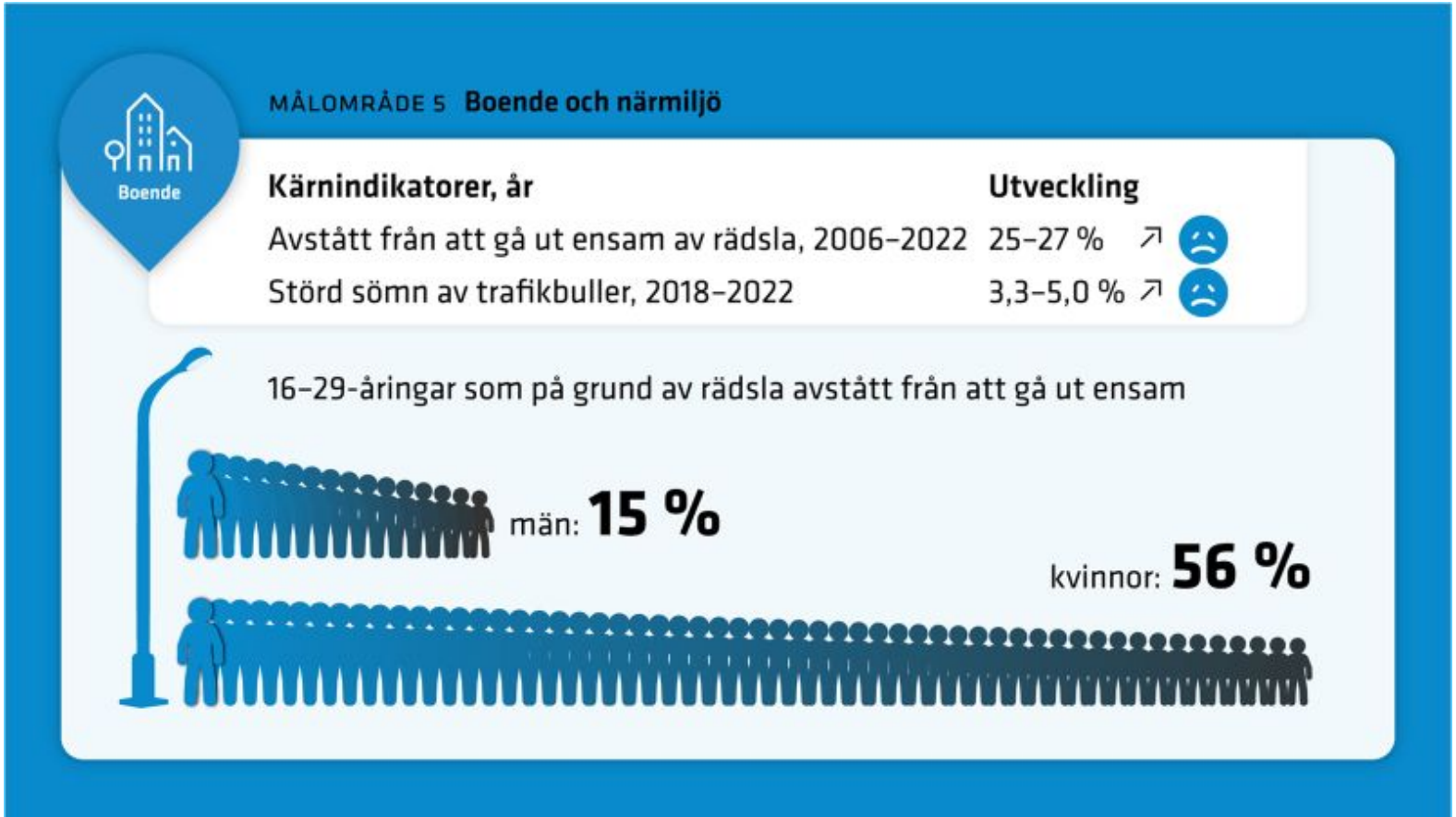
Folkhälsan i Sverige



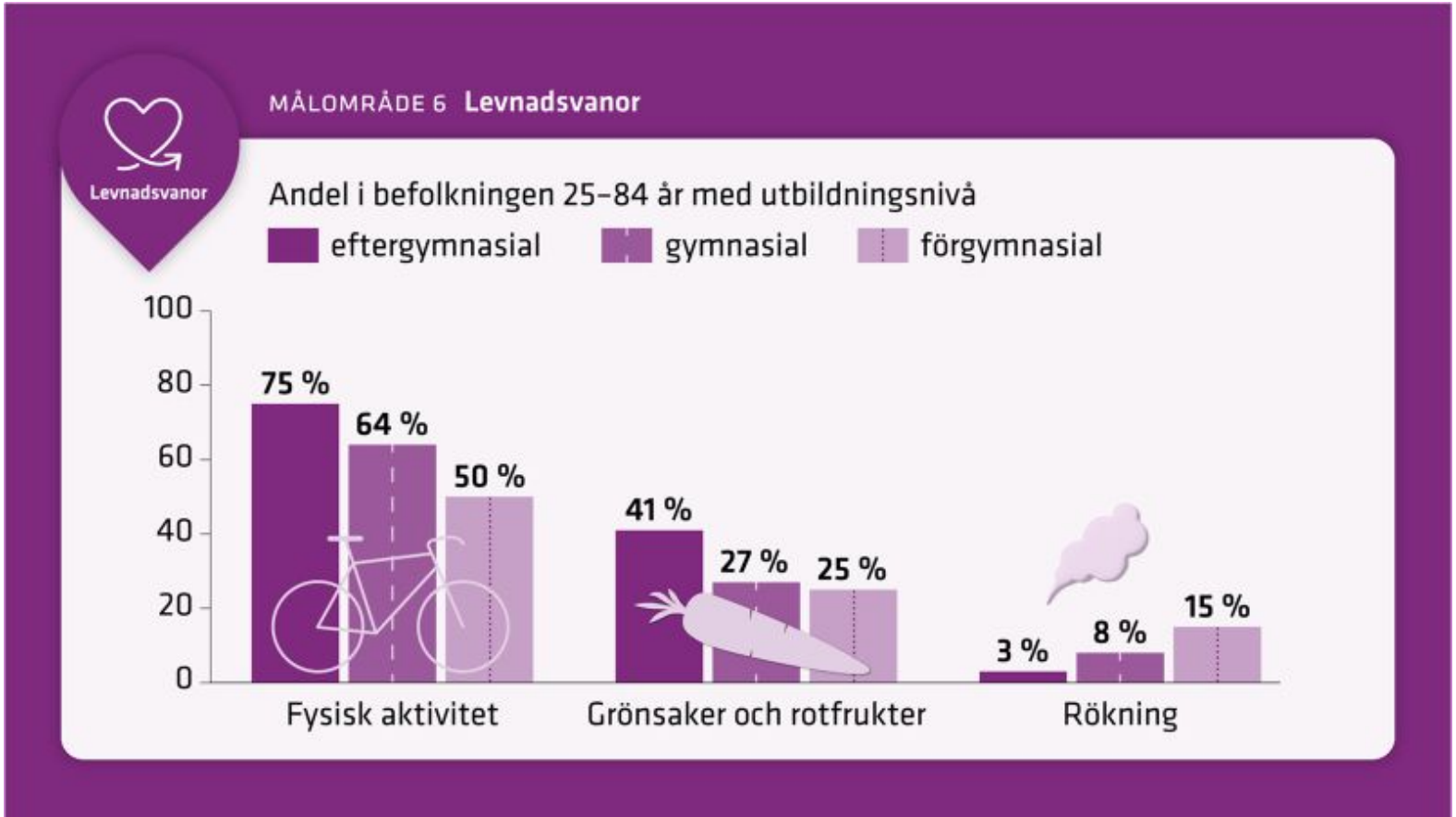
Folkhälsan i Sverige



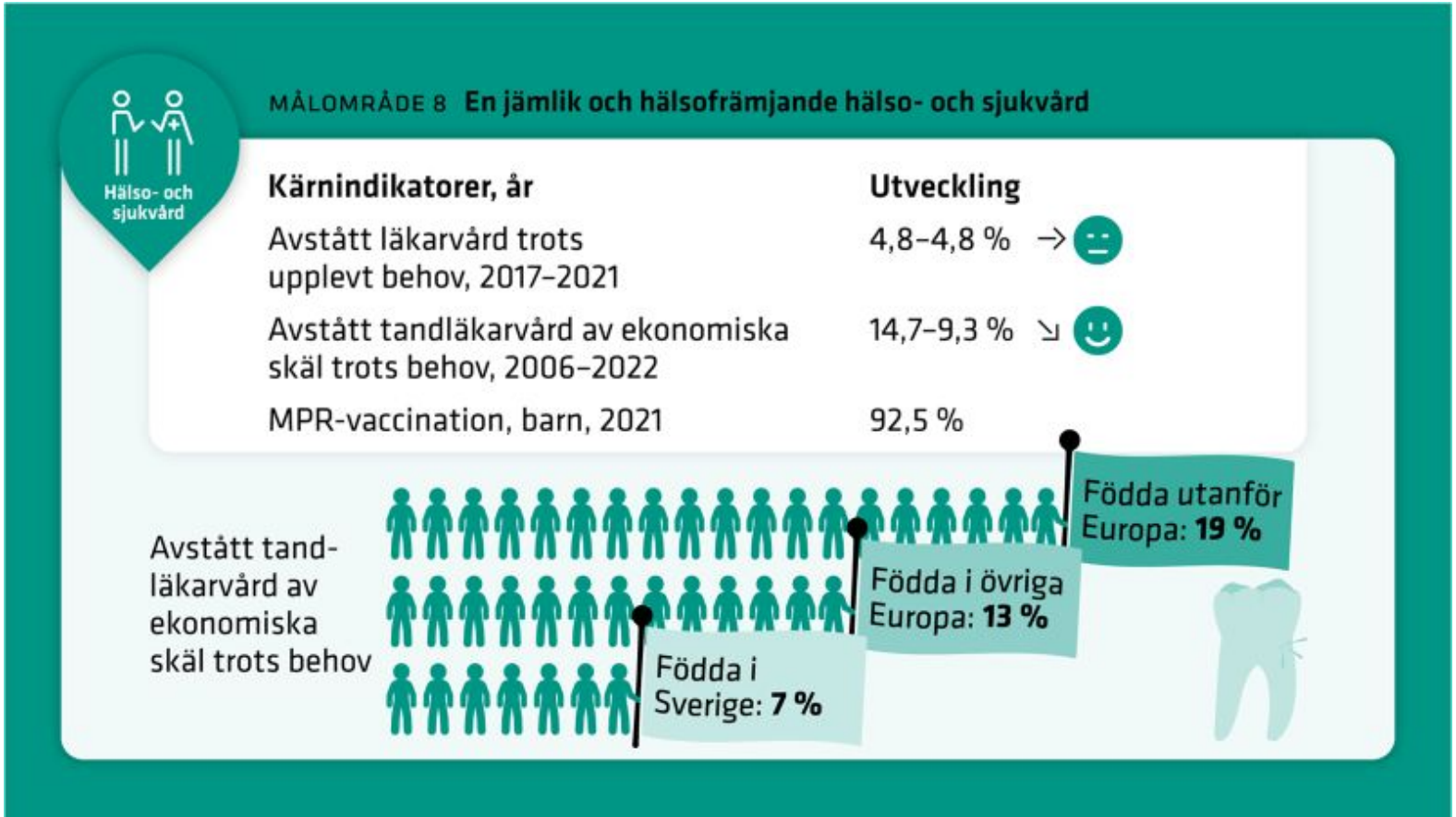
Folkhälsan i Sverige



Folkhälsan i Sverige



Folkhälsan i Sverige



Folkhälsan i Sverige

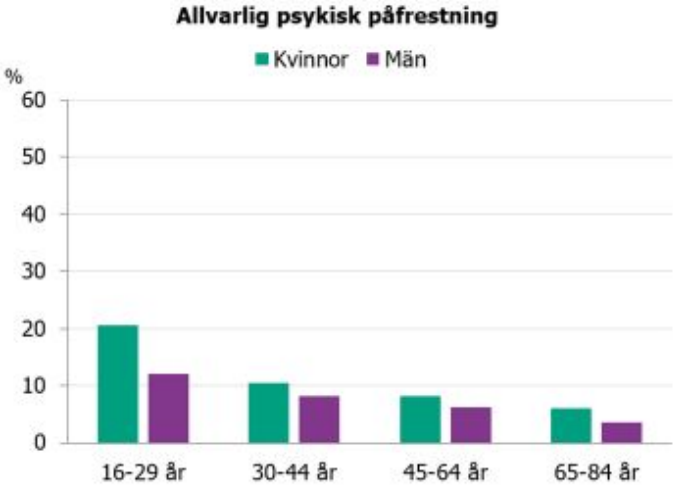
Hälsa

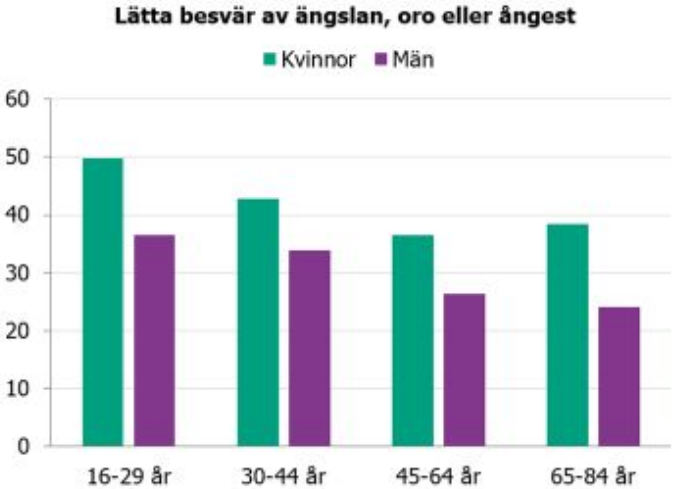
Kärnindikatorer, år	Utveckling
Självskattad hälsa, 2006–2022	69–73 % ↗
Medellivslängd, 2006–2021	81–83 år ↗
Förtida död per 100 000 invånare, 2006–2021	203–154 ↘
Allvarlig psykisk påfrestning, 2022	9 %

Medellivslängd

Folkhälsan i Sverige

Olika former av psykisk ohälsa





Folkhälsan i Sverige

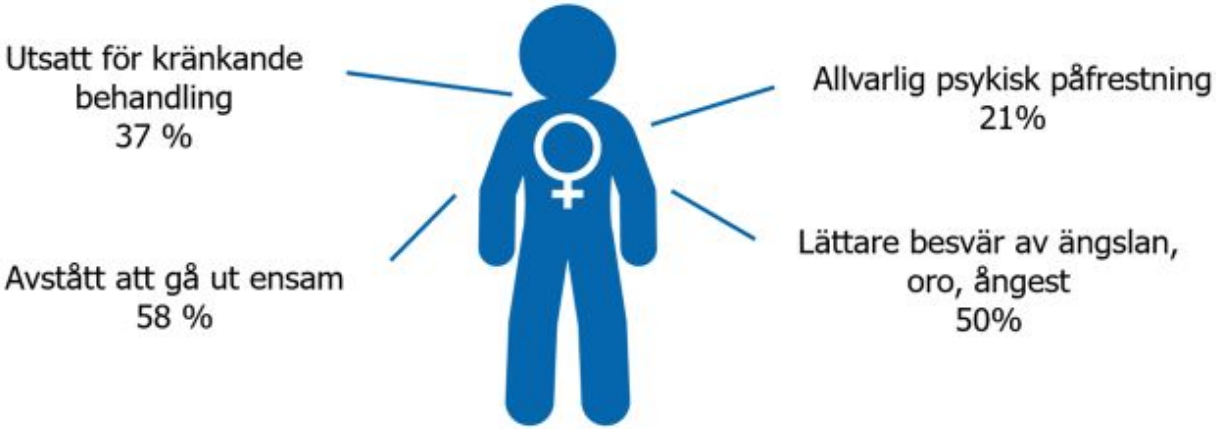
Sammanfattningsvis

Hälsan blir bättre för de flesta

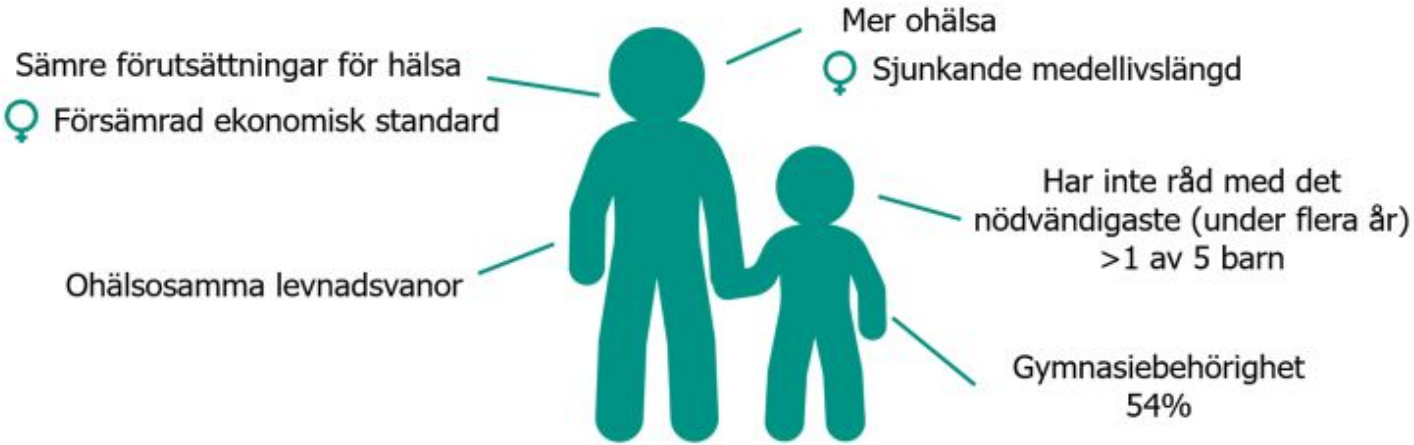
Det finns stora skillnader mellan grupper

I vissa grupper ses negativ utveckling

Unga kvinnor

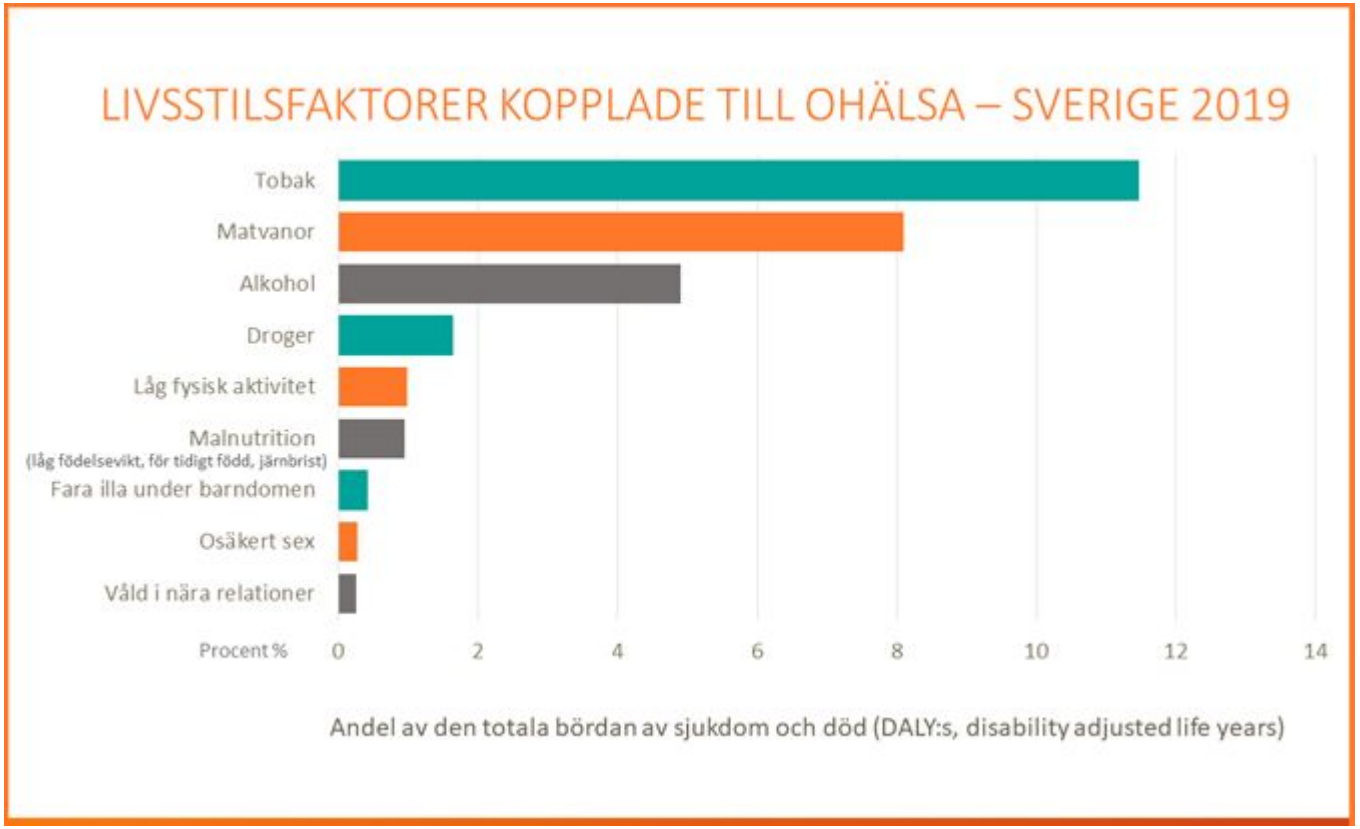


Personer med kort utbildning och deras barn



Lista dagliga vanor som påverkar er hälsa (positivt och negativt)

Livsstilsfaktorer kopplade till ohälsa



Vad betyder hälsa för er? Hur skiljer det sig mellan olika kulturer?

Brainstorma exempel på vanor inom dessa områden

Kost

Social hälsa

Rörelse

Sömn

Hur påverkar kultur och ekonomi vad vi äter?

Kultur

- Man äter det man är van vid att äta hemifrån
- Exempelvis är pasta och pizza vanligt i Italien medan köttbullar och potatis är vanligt i Sverige
- Religion → muslimer äter inte fläsk – hinduer äter inte nöt
- Medelhavsdieten (rik på olivolja, grönsaker, baljväxter och fisk) är kopplad till lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
- Traditionell japansk kost (rik på fisk, ris och grönsaker) har kopplats till hög livslängd och låg förekomst av fetma

Hur påverkar kultur och ekonomi vad vi äter?

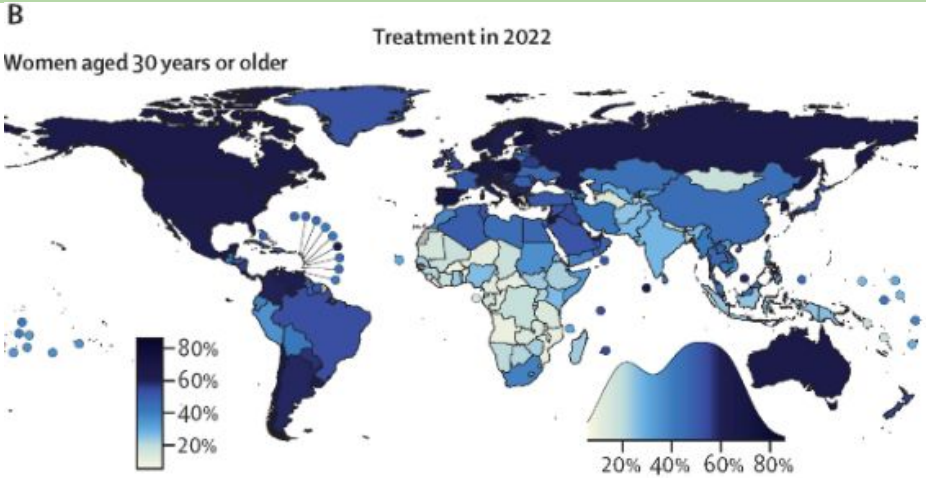
När traditionella dieter trängs undan av globaliserade matvanor (snabbmat, sockerrika drycker, och processade livsmedel) har det lett till en ökning av livsstilssjukdomar som diabetes, fetma och högt blodtryck.

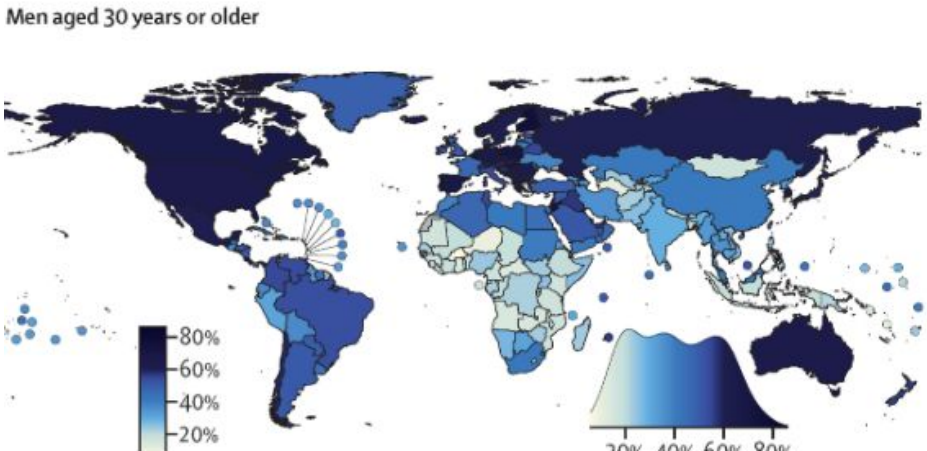
Exempel: I många utvecklingsländer som snabbt anpassar sig till västerländska matvanor har sjukdomar relaterade till fetma ökat kraftigt.

Första bilden visar hur stor procent av befolkningen som har diabetes.

Desto mörkare röd färg desto fler i befolkningen har diabetes

Nästa bild visar behandlingen. Desto mörkare blå färg desto bättre behandling är det i landet.
Vad kan ni dra för slutsatser kring det?





Reklam för snabbmat

Vad får denna reklamen er att känna?

Hur påverkar kultur och ekonomi vad vi äter?

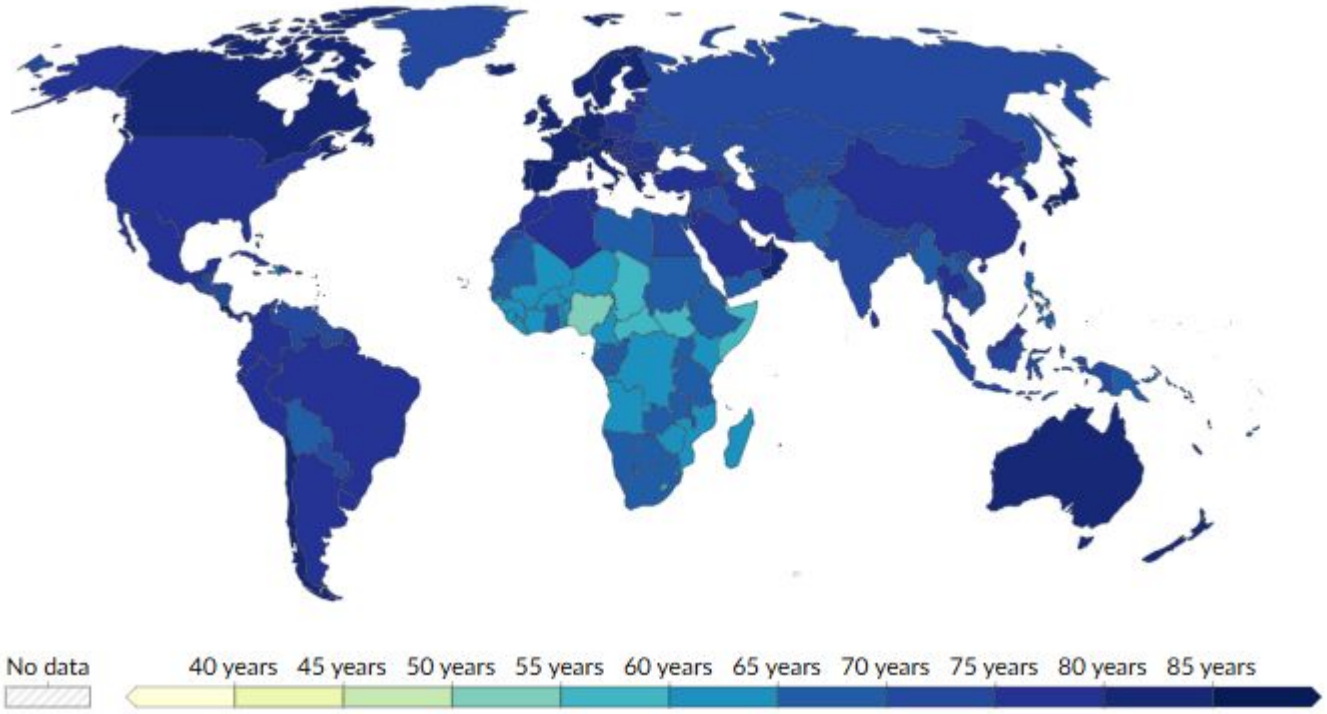
Ekonomi

- sämre ekonomi → svårare att äta “nyttigt” särskilt i vissa länder som USA
- Om en behöver jobba två jobb så hinner man kanske inte laga mat utan köper snabbmat
- Reklam för snabbmat påverkar våra matvanor
- Vissa rätter signalerar att man har pengar som hummer eller kaviar

Begreppslista!

Statistik – hälsa mellan olika länder (förväntad livslängd)

1. Gå in på https://ourworldindata.org/life-expectancy
2. Välj två länder som du tycker är intressant att jämföra – klicka i dem
3. Vad tror du skillnaden i life expectancy (förväntad livslängd) beror på?



Ni får göra denna presentationen enskilt eller i par.

Uppgiften bör ta 2 lektioner att bli klar med.

Ifall en i paret börjar få hög frånvaro kommer jag att dela på er.

Uppgift: Jämför förväntad livslängd mellan två länder

Gå in på webbplatsen Our World in Data - Life Expectancy och välj två länder som du tycker är intressanta att jämföra. Notera att de ska skilja sig när det gäller förväntad livslängd.

Besvara följande frågor och använd så många av de centrala begreppen som möjligt:

1. Vad tror du att skillnaden i förväntad livslängd beror på?
   Resonera kring olika faktorer som kan påverka livslängden.
   Jämför länderna i tabellen nedan.

Land	Land 1 + förväntad livslängd	Land 2 + förväntad livslängd
BNP per invånare		
HDI (Human development Index)		
Politiska faktorer (finns det en stabil stat? Demokrati? krig?)		
Livsvillkor (t.ex. tillgång till mat, rent vatten, bostäder och utbildning).		
Social position (hur påverkar ekonomiska/sociala skillnader hälsan i landet?)		
Livsstilsfaktorer (som kost, fysisk aktivitet, rökning, alkohol).		
Vilka folksjukdomar dominerar landet? (t.ex. hjärt-kärlsjukdom, diabetes, cancer).		
Mortalitet per 1000 invånare		

2. Reflektera över vad som skulle krävas för att uppnå bättre hälsojämlikhet både inom och mellan länder

3. Omvandla ditt arbete till en presentation – du kan använda google presentationer eller canva.